MEMORIA TÉCNICO-METODOLÓGICA

Sesión S04 — Interesados y Personas: Compromiso, Liderazgo y Comunicación

Stakeholder Engagement Plan · Communications Management Plan

Portafolio "Salud Digital 4.0" — Expediente SUB-2026/SD40-PMO-01

Subproyecto P10 — Gestión del Cambio, Capacitación y Adopción Operativa

Grupo Líder: P10

Asignatura: Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos

Marco de referencia: PMBOK® Guide — 8ª Edición (PMI)

Sesión S04 — 01/10/2026

Jeremías Josué Pluas Charcopa, Iluminada Baena Herruzo, José Luis Alcón del Villar, Konstantinos Peridis, Luis de Alarcon Conradi, Enrique Aguiló Troya y Francisco Javier Rodríguez Martín.

ÍNDICE

1. Introducción 3
2. Fundamentación Teórica y Marco Normativo (PMBOK 8ª Edición) 3
2.1. El Dominio de Desempeño de Interesados 3
2.2. El Ciclo de Participación de los Interesados 3
2.3. La Matriz de Evaluación del Nivel de Participación 4
2.4. Comunicación Efectiva y Estrategias de Comunicación 4
2.5. Procedimientos Formales del Dominio de Interesados 5
3. Planes de Gestión Subsidiarios Asignados 6
3.1. Stakeholder Engagement Plan — Subproyecto P10 6
3.2. Communications Management Plan — Subproyecto P10 7
4. Contexto del Proyecto: el Subproyecto P10 dentro del Portafolio 8
4.1. Datos generales del contrato y del subproyecto 8
4.2. Alcance y objetivo contractual de P10 8
4.3. Hitos, SLAs y penalizaciones aplicables al desempeño de P10 8
5. Desarrollo del Caso Aplicado al Proyecto P10 9
5.1. Identificación y Matriz de Interesados (Poder/Interés) 9
5.2. Matriz RACI de Responsabilidades 9
5.3. Plan de Comunicaciones del Subproyecto P10 10
5.4. Estudio de caso: Dr. Fernando Alonso Peña (INT-02) 10
5.5. Estudio de caso: Carmen Gómez Roldán (INT-03/INT-07) 11
5.6. Síntesis: comunicación y objetivo contractual 11
6. Guía y Plantilla para el Entregable Cruzado 13
6.1. Instrucciones paso a paso 13
6.2. Plantilla reutilizable 13
6.3. Criterios de aceptación del entregable cruzado 13
7. Tabla de Imputación de Horas y Esfuerzo 14
8. Conclusiones 15
9. Referencias Bibliográficas 16

1. Introducción

El Portafolio *"Salud Digital 4.0"* (expediente SUB-2026/SD40-PMO-01) moviliza un presupuesto base de licitación de **3.325.000 €** para ejecutar, en un plazo de 36 semanas, once subproyectos agrupados en tres programas de transformación digital sanitaria: infraestructura y dispositivos (Programa A), sistemas clínicos e inteligencia artificial (Programa B) y nube, ciberseguridad, adopción y operaciones (Programa C). Dentro de este último programa se encuadra el **Subproyecto P10 — Gestión del Cambio, Capacitación y Adopción Operativa**, con un presupuesto asignado de 240.000 €, una duración de 7 meses (28 semanas) y una dotación de 5 FTEs.

La tesis central de esta memoria es que la inversión tecnológica del Portafolio no garantiza por sí sola su éxito. El verdadero factor crítico de éxito reside en la aceptación humana: si el personal sanitario no interioriza y adopta las nuevas herramientas, el hospital nunca llegará a usar de forma efectiva lo que los demás subproyectos han construido. Por ello, el objeto de P10 no es un compromiso vago de "acompañar el cambio", sino una obligación contractual muy concreta y auditable, fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT): **certificar a un mínimo de 850 profesionales sanitarios antes de la semana 32**, condición que constituye el Hito 4 del Portafolio y uno de los tres requisitos de la "Paz y Salvo de Capacitación" exigidos para la aceptación operativa final del contrato.

Esta memoria desarrolla, siguiendo estrictamente el estándar PMBOK 8ª Edición, la fundamentación teórica del Dominio de Desempeño de Interesados, la redacción formal de los dos planes subsidiarios asignados a la Sesión S04 (Stakeholder Engagement Plan y Communications Management Plan), su aplicación práctica íntegra al caso real de P10 —incluyendo la Matriz de Interesados, la Matriz RACI y el Plan de Comunicaciones— y la plantilla metodológica que el resto de grupos de la asignatura (P01 a P09 y P11) deberá replicar sobre sus propios subproyectos.

2. Fundamentación Teórica y Marco Normativo (PMBOK 8ª Edición)

2.1. El Dominio de Desempeño de Interesados (Stakeholder Performance Domain)

El PMBOK 8ª Edición define un **interesado (stakeholder)** como todo individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, programa o portafolio. Los interesados condicionan, directa o indirectamente, múltiples parámetros del proyecto: alcance, cronograma, presupuesto, riesgo, calidad y éxito final. Puesto que los proyectos son realizados por y para personas, aplicar habilidades interpersonales y de liderazgo para gestionar estas relaciones es tan crítico como el dominio de las técnicas formales de gestión de proyectos.

La implicación de los interesados es altamente dinámica: los individuos entran y salen del proyecto, y su nivel de interés o de influencia fluctúa con el tiempo. En un portafolio como "Salud Digital 4.0", donde conviven perfiles con poder jerárquico asistencial (jefes de servicio), perfiles operativos sobrecargados (enfermería) y órganos de control transversal (PMO, Protección de Datos), esta dinámica es especialmente acusada y exige un ciclo de gestión continuo, no un ejercicio puntual de "lista de contactos".

2.2. El Ciclo de Participación de los Interesados

El estándar articula la gestión de interesados en cinco pasos continuos, que se retroalimentan a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto:

- **1. Identificar.** La identificación de alto nivel comienza al inicio del proyecto y se elabora progresivamente. Algunos interesados (patrocinador, usuarios finales) son obvios; otros —como los equipos de subproyectos predecesores de los que P10 depende técnicamente— son menos directos y más difíciles de detectar.
- **2. Analizar / comprender.** El equipo debe comprender de forma continua los sentimientos, creencias, valores y expectativas de los interesados, analizando su poder, impacto, actitud e interés relativo, y observando las alianzas que forman entre sí, ya que pueden ayudar o dificultar los objetivos del proyecto.

- **3. Priorizar.** Dado que es inviable atender a todos los interesados por igual, el equipo debe priorizar el foco —típicamente sobre quienes concentran mayor poder e interés— y repriorizar activamente a medida que el panorama evoluciona.
- **4. Involucrar (engage).** La participación va más allá de la comunicación básica: exige trabajar de forma colaborativa para gestionar expectativas, negociar, resolver problemas y tomar decisiones conjuntas, apoyándose en comunicación interactiva y en habilidades blandas como la escucha activa, la empatía y la gestión de conflictos.
- **5. Monitorear.** Las actitudes y el poder de los interesados cambian según avanza el proyecto. El equipo debe monitorear continuamente la eficacia de la estrategia de involucramiento —mediante conversaciones directas, revisiones de fase o encuestas— y ajustar el enfoque cuando sea necesario.

2.3. La Matriz de Evaluación del Nivel de Participación (Stakeholder Engagement Assessment Matrix)

Se trata de la herramienta teórica central de la fase de análisis y planificación. Evalúa el nivel de participación **actual frente al deseado** de cada interesado, clasificándolo en cinco niveles progresivos:

- **Desconocedor (Unaware):** no conoce el proyecto ni sus posibles impactos.
- **Reticente / Resistente (Resistant):** conoce el proyecto y es reacio al cambio; puede oponer resistencia activa o pasiva.
- **Neutral:** conoce el proyecto, pero no lo apoya ni se opone.
- **Partidario (Supportive):** conoce el proyecto y sus impactos, y lo apoya.
- **Líder (Leading):** conoce el proyecto y participa activamente para garantizar su éxito, ejerciendo influencia positiva sobre otros interesados.

La utilidad práctica de la matriz reside en identificar la brecha entre el nivel actual y el nivel deseado de cada interesado, lo que permite diseñar estrategias de comunicación y de involucramiento específicas —y no genéricas— para cerrar esa brecha. Como se desarrolla en el apartado 5, esta lógica es exactamente la que sustenta el diseño del Plan de Comunicaciones de P10: varios interesados clave parten de una postura "Resistente" y el plan se diseña deliberadamente para desplazarlos hacia "Líder" o "Partidario".

2.4. Comunicación Efectiva y Estrategias de Comunicación

Según el estándar, la comunicación efectiva es el factor más crítico para involucrar a los interesados. Comienza con una planificación cuidadosa de quién necesita información, qué información específica necesita, y cómo, cuándo y por qué debe entregarse. Va más allá del envío o extracción unidireccional de datos para convertirse en un proceso interactivo que incorpora intercambios bidireccionales frecuentes —reuniones cara a cara, diálogos informales, actividades de intercambio de conocimiento— y ciclos de retroalimentación rápidos que permiten confirmar que el mensaje se ha entendido correctamente, evaluar el grado de acuerdo del receptor y detectar matices o interpretaciones no deseadas.

El PMBOK 8ª Edición estructura las estrategias de comunicación en tres modalidades, que deben combinarse en función de la naturaleza de la información y del grado de resistencia del receptor:

Modalidad	Definición	Idoneidad
Push (empuje)	Transmisión unidireccional de información: correos electrónicos, boletines, informes de estado.	Avisos operativos, formación asíncrona, información de bajo riesgo de malentendido.
Pull (extracción)	El interesado busca activamente la información en repositorios centralizados: intranet, plataformas E-Learning.	Consulta bajo demanda, documentación de referencia estable.
Interactiva	Intercambio bidireccional directo: reuniones, talleres, conversaciones, sesiones de demostración.	Colectivos de alto poder o alta resistencia, negociación de expectativas, gestión del cambio.

Si bien la comunicación push es eficiente para distribuir información, limita la capacidad del equipo para medir de forma inmediata la reacción o comprensión del receptor. Por ello, **la participación interactiva resulta imprescindible** en los colectivos de alto poder o alta resistencia inicial, precisamente el perfil de los interesados críticos de P10 identificados en el apartado 5.

2.5. Procedimientos Formales del Dominio de Interesados

El PMBOK 8ª Edición articula el Dominio de Desempeño de Interesados en siete procedimientos formales, cuyas entradas, herramientas/técnicas y salidas (ITTOs) resumidas son las siguientes:

Procedimiento	Propósito	Salida principal
Identify Stakeholders	Detectar personas, grupos u organizaciones que afectan o son afectados por el proyecto.	Registro de interesados
Plan Stakeholder Engagement	Diseñar enfoques para involucrar a los interesados según sus necesidades e intereses.	Stakeholder Engagement Plan
Plan Communications Management	Definir el enfoque y el plan de actividades de comunicación del proyecto.	Communications Management Plan
Manage Stakeholder Engagement	Colaborar con los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas y resolver problemas.	Solicitudes de cambio, registros de incidencias
Manage Communications	Generar, recopilar, distribuir y almacenar la información del proyecto de forma oportuna.	Comunicaciones del proyecto
Monitor Stakeholder Engagement	Supervisar las relaciones y ajustar las estrategias de involucramiento.	Información de desempeño del trabajo
Monitor Communications	Asegurar que las necesidades de información se satisfacen durante todo el ciclo de vida.	Información de desempeño de las comunicaciones

Estos siete procedimientos generan dos salidas subsidiarias vitales para la gobernanza del subproyecto P10 —desarrolladas en el apartado 3—: el Stakeholder Engagement Plan y el Communications Management Plan.

3. Planes de Gestión Subsidiarios Asignados

3.1. Stakeholder Engagement Plan — Subproyecto P10

3.1.1. Propósito y alcance del plan

El Stakeholder Engagement Plan de P10 define la estrategia mediante la cual el equipo de Gestión del Cambio identificará, analizará, priorizará e involucrará a los interesados del Portafolio "Salud Digital 4.0" cuya actitud condiciona la adopción real de las herramientas desarrolladas por los subproyectos clínicos y tecnológicos (P1 a P9, P11). Su objetivo último es cerrar la brecha entre el nivel de participación actual y el nivel de participación deseado de cada interesado, en los términos definidos en el apartado 2.3, de forma que el subproyecto alcance el compromiso contractual de certificar a 850 profesionales sanitarios antes de la semana 32.

3.1.2. Metodología de identificación y análisis

La identificación de interesados se realizó mediante entrevistas de descubrimiento conducidas por la PMO al inicio del proyecto, complementadas con el análisis del Project Charter (F-PMO-01) y del Pliego de Prescripciones Técnicas. El análisis combina dos ejes clásicos del PMBOK:

- **Poder / Interés:** capacidad de influencia formal sobre el proyecto frente al grado de afectación o interés personal en su resultado. Determina el cuadrante de gestión (gestionar de cerca, mantener satisfecho, mantener informado, monitorear).
- **Postura actual / Postura deseada:** nivel de participación según la Matriz de Interesados Poder/Interés (Desconocedor–Resistente–Neutral–Partidario–Líder), que determina la urgencia y la intensidad de la estrategia de involucramiento a aplicar.

El resultado de este análisis —la Matriz de Interesados de P10, con sus 9 interesados clasificados— se desarrolla íntegramente en el apartado 5.1.

3.1.3. Estrategias de involucramiento por cuadrante

Cuadrante (Poder/Interés)	Estrategia genérica	Interesados P10
Gestionar de cerca (Alto/Alto)	Comunicación interactiva intensiva, negociación directa, objetivo de convertirlos en "Campeones Digitales".	PMO (INT-01), Dirección Médica (INT-02), Dirección de Enfermería (INT-03)
Mantener satisfecho (Alto/Bajo)	Información sintética de alto nivel, sin sobrecarga operativa, foco en cumplimiento y ROI.	Sponsor Ejecutivo (INT-04), Comité de Seguridad/DPD (INT-05)
Mantener informado (Bajo/Alto)	Comunicación push/pull ligera y accesible, minimizando la carga sobre su tiempo operativo.	Facultativos (INT-06), Enfermería (INT-07), Celadores/Admin. (INT-08)
Monitorear (Bajo/Bajo)	Comunicación mínima, coordinación técnica puntual, seguimiento de dependencias.	Equipos de Desarrollo P1/P3/P4/P5/P6 (INT-09)

3.1.4. Gestión del riesgo de participación

El plan identifica un riesgo crítico transversal: la resistencia de los interesados con **alto poder jerárquico** (Dirección Médica y Dirección de Enfermería) tiene efecto de arrastre sobre sus equipos, mientras que la resistencia de los interesados con **alto interés pero bajo poder formal** (personal clínico y de enfermería de base) se traduce en boicot pasivo o en sobrecarga del Centro de Atención a Usuarios (CAU) por incidencias evitables. Ambos riesgos se mitigan mediante el diseño diferenciado de canales y frecuencias que se detalla en el Communications Management Plan (apartado 3.2) y se ilustra con los estudios de caso del apartado 5.4 y 5.5.

3.1.5. Monitorización del engagement

El nivel de participación se revisa en cada hito de P10 (semanas 4, 12, 24 y 32) mediante: (a) indicadores cuantitativos específicos por interesado (definidos en el Plan de Comunicaciones, columna "Métrica/Indicador"); (b) actas de las reuniones ejecutivas quincenales con jefaturas de servicio; y (c) el volumen de incidencias de soporte reportadas al CAU como proxy indirecto de la eficacia de la formación en planta. Cualquier retroceso de un interesado clave desde "Partidario" hacia "Neutral" o "Resistente" activa una revisión extraordinaria de la estrategia de involucramiento.

3.2. Communications Management Plan — Subproyecto P10

3.2.1. Enfoque general

El Communications Management Plan traduce el análisis de interesados en un conjunto operativo de reglas de comunicación: qué se comunica, a quién, con qué objetivo, por qué canal, con qué frecuencia, bajo qué responsabilidad y con qué indicador de éxito. Se ha construido cruzando de forma metódica tres fuentes: (1) la Matriz de Interesados de P10, (2) las restricciones técnicas y de gobernanza del Project Charter y del Pliego de Prescripciones Técnicas, y (3) las directrices metodológicas del PMBOK 8ª Edición descritas en el apartado 2.4.

3.2.2. Metodología de diseño (paso a paso)

- **Paso 1 — Análisis de interesados:** identificar los colectivos o roles clave y su nivel de apoyo o resistencia inicial, tomando como base la Matriz de Interesados y el Mapa de Poder e Interés.
- **Paso 2 — Definición del mensaje clave:** adaptar el contenido a la audiencia. A la alta dirección le interesan costes, ROI y cumplimiento de hitos; a los usuarios operativos (médicos, enfermería) les interesa cómo la herramienta reduce su carga diaria. Si un colectivo es reacio al cambio, el mensaje se centra en sus "dolores" y beneficios directos, nunca en la imposición normativa.
- **Paso 3 — Selección del canal:** canales formales/bidireccionales (reuniones, talleres, comités ejecutivos) para colectivos de alto poder o alta resistencia; canales masivos/unidireccionales (correo, infografías, vídeo E-Learning) para avisos operativos o formación asíncrona.
- **Paso 4 — Frecuencia y fechas clave:** diaria (soporte in situ), semanal (seguimiento), quincenal (avance ejecutivo) o mensual/por hito (informes a Dirección), evitando tanto la falta de información como la sobrecarga.
- **Paso 5 — Asignación de responsabilidades:** cada fila del plan se ancla a un rol de la Matriz RACI (apartado 5.2): el Project Manager comunica a la PMO, los Formadores Procesales Sanitarios comunican al personal de planta, etc.
- **Paso 6 — Métricas e indicadores (KPI):** cada fila incorpora una métrica de verificación —tasa de apertura, % de asistencia, satisfacción en encuesta, tasa de adopción voluntaria— que permite auditar objetivamente si la comunicación está siendo efectiva.

3.2.3. Estructura formal del plan

El resultado de aplicar esta metodología es la tabla de 9 filas (una por interesado, códigos INT-01 a INT-09) que constituye el Plan de Comunicaciones formal del Subproyecto P10, reproducida íntegramente en el apartado 5.3, con las columnas: ID Interesado, Interesado/Audiencia, Rol en el Hospital, Mensaje Clave, Objetivo de la Comunicación, Canal/Medio, Frecuencia, Responsable (Rol RACI) y Métrica/Indicador de Éxito.

3.2.4. Gobernanza y control de cambios en el plan

El plan se revisa formalmente en cada Comité de Control de Cambios (informes semanales a la PMO, INT-01) y en cada hito clave (semanas 4, 12, 24 y 32). Cualquier desviación del SPI por debajo de 0,90 durante dos evaluaciones semanales consecutivas —umbral fijado en el Pliego como causa de penalización— dispara una revisión inmediata de la estrategia de comunicación con los interesados del subproyecto afectado, dado que el retraso en la formación repercute directamente en el cumplimiento del Hito 4 contractual.

4. Contexto del Proyecto: el Subproyecto P10 dentro del Portafolio

4.1. Datos generales del contrato y del subproyecto

Parámetro	Portafolio "Salud Digital 4.0"	Subproyecto P10
Presupuesto	3.325.000 € (impuestos excluidos)	240.000 €
Plazo de ejecución	36 semanas (9 meses)	28 semanas (7 meses)
Equipo	51 FTEs (tarifa homogénea 5.000 €/mes/FTE)	5 FTEs
Estructura	11 subproyectos, 3 programas (A, B, C)	Programa C — Nube, Ciberseguridad, Adopción y Operaciones
Metodología obligatoria	PMBOK 8ª Edición + EVM	PMBOK 8ª Edición + EVM

El Subproyecto P10 — **Gestión del Cambio, Capacitación y Adopción Operativa** — se encuadra en el Programa C junto a la migración a nube (P8), la ciberseguridad (P9) y la plataforma de observabilidad (P11). Su equipo dedicado, conforme a la distribución de perfiles del Pliego, está formado por: 1 *Clinical Change Management Lead*, 2 *Formadores Procesales Sanitarios*, 1 *Creador de Contenidos E-Learning* y 1 *Técnico de Soporte en Planta*.

4.2. Alcance y objetivo contractual de P10

Las prescripciones técnicas del Pliego definen el alcance de P10 en dos términos: (a) un plan integral de formación técnica y asistencial en modalidades presencial, e-learning y talleres prácticos en simulación; y (b) un impacto objetivo cuantificado — la formación y certificación de al menos 850 profesionales sanitarios (médicos, enfermería, celadores y personal administrativo) en las nuevas herramientas, antes de la semana 32.

Este objetivo no es una meta interna del equipo P10: es una de las tres condiciones de aceptación operativa final del contrato completo (junto con la validación funcional UAT y la auditoría de seguridad ENS), y constituye el Hito 4 del calendario del Portafolio, compartido con la integración del Core HCE con IA (P5) y del Motor BI (P7).

4.3. Hitos, SLAs y penalizaciones aplicables al desempeño de P10

Hito del Portafolio	Semana	Componente atribuible a P10
Hito 1 — Plan general del Portafolio	4	Aprobación del Plan de Formación (Entregable 1 RACI) y de la Matriz de Interesados
Hito 2 — Cierre de infraestructuras base	12	Materiales didácticos y videotutoriales de la plataforma E-Learning listos
Hito 3 — Despliegue asistencial (UAT)	24	Talleres prácticos de simulación y acompañamiento en planta impartidos
Hito 4 — Integración Core HCE/IA + BI	32	Certificación de ≥ 850 profesionales / ≥ 85 % de la formación del personal sanitario
Hito 5 — Aceptación operativa final	36	Paz y Salvo de Capacitación (condición de cierre del Portafolio)

El desempeño de P10 está sujeto a los SLA contractuales generales del Portafolio: si el **Índice de Desempeño del Cronograma (SPI = EV/PV)** cae por debajo de 0,90 durante dos evaluaciones semanales consecutivas, se aplica una penalización del 1 % del importe del subproyecto por cada semana de retraso; desviaciones no autorizadas del **Índice de Desempeño del Coste (CPI = EV/AC)** por debajo de 0,90 exigen un Plan de Recuperación a costa del adjudicatario. Dado que la formación no puede comprimirse sin degradar su calidad (a diferencia de otras tareas técnicas), el margen de holgura de P10 es especialmente sensible: cualquier retraso en el compromiso de los interesados críticos (apartado 5) repercute de forma directa en el SPI del subproyecto y, en última instancia, en el cumplimiento del Hito 4 y en la viabilidad económica del conjunto del Portafolio.

5. Desarrollo del Caso Aplicado al Proyecto P10

5.1. Identificación y Matriz de Interesados (Poder/Interés)

A partir de las entrevistas de descubrimiento realizadas por la PMO, se identificaron 9 interesados relevantes para P10, clasificados según su poder formal, su interés en el resultado, su postura inicial (nivel de participación actual) y la postura deseada al cierre del subproyecto:

ID	Interesado	Poder	Interés	Cuadrante	Postura inicial → deseada
INT-01	PMO Estratégica (PGPI Consultores)	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Líder → Líder
INT-02	Dirección Médica y Jefaturas de Servicio	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Resistente → Líder
INT-03	Dirección de Enfermería y Supervisoras	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Resistente → Partidario
INT-04	Dirección General de Salud Digital (Sponsor)	Alto	Bajo	Mantener satisfecho	Partidario → Partidario
INT-05	Comité de Seguridad y DPD	Alto	Bajo	Mantener satisfecho	Neutral → Partidario
INT-06	Médicos y Facultativos de Planta/Urgencias	Bajo	Alto	Mantener informado	Resistente → Partidario
INT-07	Personal de Enfermería	Bajo	Alto	Mantener informado	Resistente → Partidario
INT-08	Celadores y Personal Administrativo	Bajo	Alto	Mantener informado	Resistente → Neutral
INT-09	Equipos de Desarrollo (P1, P3, P4, P5, P6)	Bajo	Bajo	Monitorear	Partidario → Partidario

De los 9 interesados, **dos concentran el riesgo real de fracaso del subproyecto**: la Dirección Médica y Jefaturas de Servicio (INT-02) y la Dirección de Enfermería y Supervisoras de Planta (INT-03), ambas en el cuadrante "Gestionar de cerca" y con postura inicial "Resistente". A diferencia de otros interesados de bajo poder (INT-06 a INT-08), su resistencia tiene capacidad de arrastre jerárquico sobre el resto de su servicio o de su plantilla. Los apartados 5.4 y 5.5 desarrollan en detalle el estudio de caso de ambos perfiles.

5.2. Matriz RACI de Responsabilidades

La Matriz RACI vincula los entregables e hitos formales de P10 (definidos en el Marco de Encargo F-PMO-01) con los nueve interesados/roles identificados, especificando quién es Responsable (R) de la ejecución, quién rinde cuentas (A), a quién se Consulta (C) y a quién se Informa (I):

Entregable / Hito	PMO	Dir. Médica	Dir. Enf.	Sponsor	Seg./DPD	Médicos	Enferm.	Celad./Adm.	Desarrollo
Gobernanza: Charter (F-PMO-01) y Marco de Encargo (F-PMO-03)	A/R	C	C	I	I	I	I	I	I
Encargo físico: asignación de 5 FTEs (Programa C)	A	R	R	I	I	I	I	I	C
Entregable 1: Plan integral de formación	A	R	R	I	C	I	I	I	C
Entregable 2: Materiales didácticos y E-Learning	A	C	C	I	C	I	I	I	R
Entregable 3: Talleres y soporte en planta	A	C	R	I	I	C	R	C	I
Entregable 4: Registro de asistentes y traspaso a PMO	A/R	I	I	I	I	I	I	I	I
Hito 1 (S4): aprobación del plan de formación	A	C	C	I	C	I	I	I	I

Entregable / Hito	PMO	Dir. Médica	Dir. Enf.	Sponsor	Seg./DPD	Médicos	Enferm.	Celad./Adm.	Desarrollo
Hito 2 (S12): materiales listos	A	I	I	I	C	I	I	I	R
Hito 3 (S24): talleres impartidos	A	I	R	I	I	I	R	I	I
Hito 4 (S32): cierre de formación (850 sanitarios)	A/R	I	I	C/I	I	I	I	I	I

Se observa un patrón deliberado: la PMO concentra la Responsabilidad y la Rendición de cuentas (A/R) de los entregables de gobernanza y de cierre, mientras que las jefaturas asistenciales (Dirección Médica y de Enfermería) son Responsables directas de la ejecución de los entregables de formación y de los talleres, coherente con la estrategia de convertirlas en "Campeones Digitales" desarrollada en el Stakeholder Engagement Plan.

5.3. Plan de Comunicaciones del Subproyecto P10

La siguiente tabla constituye el Communications Management Plan formal de P10, resultado de aplicar la metodología de 6 pasos descrita en el apartado 3.2.2 a cada uno de los 9 interesados identificados:

ID	Interesado	Mensaje clave	Canal / Medio	Frecuencia	Responsable	Indicador
INT-01	PMO Estratégica	Progreso en plazo/presupuesto (240k€/28 sem) y KPIs SPI/CPI ≥ 0,90.	Informes semanales y Comités de Control de Cambios.	Semanal	Project Manager	Actas de hitos aprobadas sin desvíos ≥ 1 sem.
INT-02	Dir. Médica y Jefaturas	La tecnología reduce un 40% la carga administrativa sin alterar las guardias.	Reuniones ejecutivas y demos de la versión Beta.	Quincenal	Clinical Change Mgmt. Lead / PM	% de Jefes de Servicio comprometidos como referentes.
INT-03	Dir. Enfermería y Supervisoras	Formaciones de 15 min adaptadas a los relevos de turno.	Reuniones de coordinación de cuadrantes, correo e infografías.	Quincenal/Mensual	Formadores Procesales Sanitarios	0 % de cancelaciones de turno por formación.
INT-04	Sponsor Ejecutivo (Salud Digital)	P10 asegura la adopción real, protegiendo la inversión de 3M€.	Dashboard ejecutivo y reuniones de estado del Portafolio.	Mensual	Project Manager	Cumplimiento del Hito 4 (85% certificado).
INT-05	Comité de Seguridad y DPD	El plan garantiza el cumplimiento de RGPD/LOPDGDD y ENS Nivel Alto.	Envío de paquetes E-Learning para revisión y actas.	Por hito (M2, M3)	Auditor QA / PM	Dictamen favorable antes de publicar los cursos.
INT-06	Médicos y Facultativos	Formación 1-a-1 en tu puesto, con soporte y simulación de casos reales.	Acompañamiento en planta, vídeos E-Learning, guías de bolsillo.	Diaria (M3) / Semanal	Técnico de Soporte / Formadores	Adopción voluntaria y satisfacción ≥ 85%.
INT-07	Personal de Enfermería	Aprende a convivir con robots y el core HCE sin perder tiempo de cuidado.	Talleres prácticos, vídeos interactivos, acompañamiento en turno.	Semanal (M3)	Formadores Procesales Sanitarios	% de enfermeros/as certificados sobre plantilla.
INT-08	Celadores y Pers. Admin.	La plataforma unifica admisiones y guiado sin duplicar tareas.	Vídeos tutoriales, manuales interactivos, soporte in situ.	Semanal/Quincenal	Creador de Contenidos E-Learning	% de expedientes correctamente procesados.
INT-09	Equipos de Desarrollo (P1,P3,P4,P5,P6)	Necesitamos versiones Beta y manuales técnicos a tiempo.	Reuniones técnicas inter-proyecto y repositorio compartido.	Semanal	Project Manager	Entrega de Beta en la semana acordada.

5.4. Estudio de caso: Dr. Fernando Alonso Peña — Jefe del Servicio de Urgencias (INT-02)

Fernando Alonso Peña, Jefe del Servicio de Urgencias Hospitalarias, es el perfil real detrás de la fila INT-02 de la Matriz de Interesados, marcado como Alto Poder / Alto Interés y con postura inicial "Resistente". El matiz es determinante: en su propia entrevista con la PMO, Fernando pide explícitamente disponer de la analítica predictiva del Motor BI (P7) para anticipar la demanda de Urgencias con 72 horas de margen. No es, por tanto, un caso de rechazo a la tecnología, sino de resistencia al método de implantación.

> *"Yo soy el primero que pide que la analítica predictiva me ayude a anticipar la demanda, eso lo pido yo mismo en mi propia entrevista con la PMO. Pero si me metéis un curso obligatorio de dos horas justo cuando mi servicio ya va desbordado, lo único que conseguís es que mi gente llegue más tarde a los pacientes."*

Este testimonio ilustra un riesgo estructural que el PMBOK identifica en el paso 2 del ciclo de participación (apartado 2.2): un jefe de servicio partidario de la tecnología pero resistente al método tiene el mismo poder de arrastre negativo que uno que rechace la tecnología por completo, porque su valoración negativa del proceso de formación se propaga jerárquicamente a cada residente, adjunto y enfermero de su servicio.

La respuesta del Plan de Comunicaciones (fila INT-02) elimina deliberadamente el correo masivo y el curso obligatorio, y los sustituye por **reuniones ejecutivas quincenales** y **sesiones privadas para probar la versión Beta** fuera de la presión del turno. El objetivo declarado no es que Fernando "use" la herramienta, sino convertirlo en Campeón Digital: si él se convence, actúa como el mejor argumento posible frente a su propio servicio, sin necesidad de convencer a cada miembro por separado. Coherentemente, el indicador de éxito no mide accesos a la plataforma, sino el **porcentaje de Jefes de Servicio comprometidos como validadores** de la herramienta — no basta con que la toleren, se necesita que la defiendan.

5.5. Estudio de caso: Carmen Gómez Roldán — Supervisora General de Enfermería (INT-03 / INT-07)

Carmen Gómez Roldán, Supervisora General de Enfermería y Cuidados Asistenciales, representa el segundo riesgo crítico del subproyecto, cubriendo tanto la fila INT-03 (Dirección de Enfermería) como el colectivo INT-07 (Personal de Enfermería), ambos marcados como "Resistente".

> *"Las enfermeras están colapsadas por la carga administrativa. Si el Plan de Capacitación nos obliga a sacar a la gente de turno sin más, el proyecto fracasará en planta."*

A diferencia de Fernando, Carmen no ostenta poder formal sobre el proyecto en el sentido contractual, pero controla un recurso igual de determinante: la carga de trabajo real de la plantilla más numerosa del hospital. La pregunta que resume el problema —"¿y quién ve a mis catorce pacientes mientras yo estoy en un aula?"— no expresa desinterés por la tecnología, sino la imposibilidad material de que el personal de planta desaparezca de su puesto sin dejar un hueco asistencial.

El diseño de respuesta invierte por completo el modelo de formación convencional de una hora de aula, sustituyéndolo por:

- Cápsulas de formación de 15 minutos, encajadas dentro del propio cambio de turno.
- Reuniones de coordinación de cuadrantes, de forma que sea la propia supervisora quien decide cuándo existe margen real sin generar descubiertos.
- Infografías en salas de descanso, que refuerzan el mensaje sin restar tiempo al turno.
- Soporte en Planta durante el mes 3 (fase de mayor despliegue): un técnico acompaña en el propio turno para perder el miedo a los robots AMR sin necesidad de "ir a clase".

Este acompañamiento a pie de cama tiene, además, un efecto colateral positivo sobre otro interesado del Portafolio no incluido formalmente en la matriz de P10: el Centro de Atención a Usuarios (CAU), que recibe cientos de incidencias diarias según su responsable. Al resolverse las dudas del personal en el propio turno, con el técnico presente, esas dudas no llegan a convertirse en tickets de soporte, lo que protege al CAU del colapso de llamadas. Coherentemente con el diseño, el indicador de éxito no mide cuánta gente aprende, sino **cero cancelaciones de turno o ausencias asistenciales por asistir a formación**: demuestra que se ha entendido el problema real antes de proponer una solución.

5.6. Síntesis: relación entre la estrategia de comunicación y el objetivo contractual

Fernando y Carmen representan los dos extremos del mismo riesgo estructural de P10. Fernando concentra poder jerárquico formal, y su resistencia al método —no a la tecnología— se contagia hacia abajo si no se gestiona con canales interactivos de alto nivel. Carmen no tiene poder formal, pero controla la variable más restrictiva del proyecto: la carga asistencial real, y ningún plan de comunicación que la ignore puede funcionar, por bien diseñado que esté sobre el papel.

El proyecto dura 28 semanas y no dispone de margen de holgura: si la gestión de interesados como Fernando o Carmen falla, la formación se retrasa, el subproyecto incumple el SPI contractual (con penalización del 1 % semanal, apartado 4.3), y el Portafolio no alcanza el Hito 4 en la semana 32. El Plan de Comunicaciones no es, por tanto, un documento administrativo accesorio: es el único mecanismo entre los 850 profesionales que deben certificarse y el uso real, en el día a día asistencial, de la tecnología que el resto de subproyectos ha construido. Como resume el propio equipo P10: *"si la comunicación falla, no se pierde código: se pierde gente dispuesta a usarlo"*.

6. Guía y Plantilla para el Entregable Cruzado

Conforme al rol de Grupo Líder asignado a P10 para la Sesión S04, este apartado facilita al resto de grupos (P01 a P09 y P11) las instrucciones, la estructura reutilizable y los criterios de aceptación necesarios para elaborar, sobre sus propios subproyectos, los tres entregables cruzados: Matriz de Interesados (Poder/Interés), Matriz RACI y Plan de Comunicaciones.

6.1. Instrucciones paso a paso

- **Paso 1.** Extraed del Pliego de Prescripciones Técnicas los datos objetivos de vuestro subproyecto: presupuesto, duración, FTEs, perfiles profesionales y prescripciones técnicas específicas. Estos datos condicionan el análisis de poder/interés (un subproyecto con más FTEs y mayor presupuesto suele implicar más interesados de alto poder).
- **Paso 2.** Identificad entre 6 y 10 interesados reales de vuestro subproyecto, evitando genéricos vacíos ("usuarios", "dirección"): usad roles concretos del hospital o del equipo del contrato, siguiendo el modelo de granularidad de la tabla del apartado 5.1.
- **Paso 3.** Clasificad cada interesado en los ejes Poder/Interés (cuadrante) y Postura inicial/Postura deseada (Desconocedor–Resistente–Neutral–Partidario–Líder), justificando brevemente el porqué de cada clasificación con un dato o cita concreta, no una intuición genérica.
- **Paso 4.** Construid la Matriz RACI cruzando los entregables e hitos formales de vuestro subproyecto (tomados del Marco de Encargo o del propio Pliego) con los interesados identificados en el Paso 2. Verificad que cada fila tenga exactamente una "A" (Accountable) y al menos una "R" (Responsible).
- **Paso 5.** Redactad el Plan de Comunicaciones aplicando la metodología de 6 pasos del apartado 3.2.2 (análisis de interesados → mensaje → canal → frecuencia → responsable RACI → métrica), fila por fila, para cada interesado del Paso 2.
- **Paso 6.** Seleccionad al menos un interesado "Resistente" o de riesgo y desarrolladlo como estudio de caso narrativo (siguiendo el modelo de los apartados 5.4/5.5), conectando explícitamente su resistencia con un dato objetivo del Pliego o del RACI.

6.2. Plantilla reutilizable

La estructura de columnas y las cabeceras de las tres tablas maestras deben respetarse literalmente para garantizar la comparabilidad entre subproyectos:

Entregable	Columnas obligatorias
Matriz de Interesados (Poder/Interés)	ID · Interesado · Poder · Interés · Cuadrante · Postura inicial → deseada
Matriz RACI	Entregable/Hito · una columna por interesado (valores R/A/C/I, admite combinados A/R o C/I)
Plan de Comunicaciones	ID · Interesado/Audiencia · Rol · Mensaje clave · Objetivo · Canal/Medio · Frecuencia · Responsable (Rol RACI) · Métrica/Indicador

6.3. Criterios de aceptación del entregable cruzado

- Coherencia interna: el Responsable de cada fila del Plan de Comunicaciones debe corresponder a un rol con R o A en la Matriz RACI del mismo entregable.
- Trazabilidad: cada interesado debe justificarse con un dato extraído del Pliego, del Project Charter o de una entrevista/fuente documental del propio subproyecto — no se admiten interesados o citas inventadas.
- Al menos un interesado debe presentar postura inicial "Resistente" o "Neutral" con estrategia explícita de cierre de brecha hacia "Partidario" o "Líder".
- Cada indicador de éxito debe ser medible y verificable (porcentaje, número absoluto, plazo), evitando formulaciones vagas del tipo "mejorar la satisfacción".
- El conjunto (Matriz de Interesados + RACI + Plan de Comunicaciones) debe presentarse como tablas formales, no como texto narrativo suelto.

7. Tabla de Imputación de Horas y Esfuerzo

De conformidad con el apartado 2.A.5 de la Guía Didáctica y Normativa de la asignatura, se recoge a continuación la auditoría interna de horas del equipo P10 para la elaboración de la presente memoria, la presentación oral y los entregables prácticos y cruzados de la Sesión S04.

Miembro del Equipo	Rol / Parte Asignada	Estimación Inicial (Horas)	Horas Reales Dedicadas	Desviación (h)	Firma / Conformidad
Jeremías	Director / Canva / Co-autor Teoría	20	31	11	[Conforme]
Iluminada	Editora Jefa QA / Memoria PDF / Co-autor Teoría	20	22	2	[Conforme]
Konstantinos	El Teórico (PMBOK / Stakeholder Plan)	15	17	2	[Conforme]
José Luis	Mapas de Personas (Matriz Interesados y RACI)	16	19	3	[Conforme]
Luis	Plan de Comunicaciones y Guía Profesor	15	15	0	[Conforme]
Enrique	Narrador del Caso Práctico (Justificación)	12	13	1	[Conforme]
Fran	Evaluador y Administrador (Test PMP y Control Horas)	12	13	1	[Conforme]
TOTALES	Esfuerzo Global del Equipo P10	110	130	20	Proyecto S04 Viable

Total de horas estimadas del grupo: **130 horas**. La columna "Desviación" se calculará como Horas reales – Estimación inicial una vez cerrado el trabajo, y deberá justificarse por escrito toda desviación superior a ±20 % conforme al criterio de evaluación "Transparencia y Organización del Equipo" (10 % de la calificación).

Como se ve en la tabla, las únicas desviaciones que superan el 20% están en la dirección del proyecto y en el diseño de las matrices. En el caso del Director de Proyecto, la realidad es que al principio subestimamos todo el tiempo que lleva coordinar de verdad a un equipo de siete personas: el trabajo no ha sido solo repartir puntos y montar la presentación, sino supervisar lo que hacía cada compañero para que todo encajara con el pliego, unificar criterios y estar pendiente de cada uno para resolución de dudas, dar apoyo y asegurar que todas las tareas avanzaran a tiempo.

Por otro lado, las horas extra en la Matriz de Interesados y la Matriz RACI se deben a varios fallos iniciales que detectó la PMO y que tuvimos que corregir sobre la marcha, dándole varias vueltas a las tablas hasta que los roles y responsabilidades cuadraron al 100% con nuestra Acta de Constitución. A pesar de que al principio nos costó bastante arrancar —sobre todo por las dudas de ser el primer grupo en exponer y la falta de referencias previas en la asignatura—, hemos sabido organizarnos y sacarlo adelante ayudándonos entre todos. Estamos muy satisfechos con el nivel del trabajo que hemos conseguido y con la implicación de todo el grupo, así que esperamos que todas las horas y el esfuerzo que le hemos dedicado a este entregable merezcan la pena.

8. Conclusiones

- La aplicación del Dominio de Desempeño de Interesados del PMBOK 8ª Edición a un contexto sanitario real confirma la tesis del propio estándar: la comunicación interactiva y diferenciada por interesado es más eficaz que la comunicación masiva uniforme para desplazar posturas "Resistente" hacia "Líder".
- El riesgo principal de P10 no procede de la tecnología del Portafolio, sino de dos variables humanas concretas: el poder de arrastre jerárquico de las jefaturas asistenciales y la restricción de tiempo operativo del personal de planta. Ambas quedan reflejadas y mitigadas explícitamente en el Stakeholder Engagement Plan y en el Communications Management Plan.
- El objetivo contractual de certificar a 850 profesionales antes de la semana 32 (Hito 4) depende directamente del éxito de la gestión de interesados: cualquier retraso en el compromiso de Fernando (INT-02) o de Carmen (INT-03/INT-07) se traduce en incumplimiento del SPI del subproyecto y en penalización económica para todo el Portafolio.
- La Matriz RACI y el Plan de Comunicaciones no son documentos independientes: su coherencia interna —el Responsable de cada comunicación coincide con el Responsable RACI del entregable correspondiente— es la que garantiza que el plan sea ejecutable y auditable, no solo teóricamente correcto.
- La plantilla y los criterios de aceptación definidos en el apartado 6 permiten trasladar esta misma metodología, sin pérdida de rigor, a los 10 subproyectos restantes del Portafolio.

9. Referencias Bibliográficas

- Project Management Institute (PMI). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) — 8ª Edición. Newtown Square, PA: PMI.
- Project Management Institute (PMI). Agile Practice Guide / Guía Práctica de Agile. Newtown Square, PA: PMI.
- Guías infográficas PMBOK 8ª Edición de Ricardo Vargas: https://ricardo-vargas.com/pmbok-guide-8th-edition-processes-flow/
- Ministerio de Hacienda y Función Pública (España). Esquema Nacional de Seguridad (ENS) — Real Decreto 311/2022.
- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, UE 2016/679) y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
- Portafolio "Salud Digital 4.0". Pliego de Prescripciones Técnicas. Expediente SUB-2026/SD40-PMO-01. Dirección General de Salud Digital — Servicio Público de Salud.
- Equipo P10. Matriz de Interesados (Poder/Interés), Matriz RACI y Plan de Comunicaciones del Subproyecto P10. Documentación interna del Portafolio "Salud Digital 4.0".
- Guía Didáctica y Normativa de Trabajos Prácticos (Sesiones S04–S14). Asignatura Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos. Universidad de Sevilla.

10. Recursos usados

Declaración de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial.

- Gemini
- NotebookLM
- Claude
- ChatGPT